

QCM Urgences

Q1 : 62 ans, sans suivi, dyspnée d'apparition brutale quelques heures auparavant. Histoire de perte de poids depuis plrs mois ainsi qu'un tabagisme actif. Détresse resp, marbrures jusqu'aux genoux bilat, auscultation sp, FC 120 bpm, irrégulièrement irrégulier, TA 83/62. Type de choc ?

R : choc obstructif

Auscultation cardiaque sp, donc pas de signes en faveur d'un choc cardiogène pour lequel on aurait des signes de décompensation à l'auscultation.

Apparition brusque : parle pour une EP (obstructif)

Q2 : Accident, cycliste de 60 ans, trauma isolé sévère du thorax D. Il est choqué, dyspnéique et cyanosé. Auscultation pulmonaire de la plage D muette. Mesure la plus adaptée :

- Gazométrie artérielle – non
- L'intubation trachéale – non
- Rx du thorax – non
- Drainage pleural d'emblée – ouiiii
- CT scan thoracique – non

Q2b : Rx du thorax = hémothorax.

Q3 : 24 ans, quelques minutes après avoir été piquée par un insecte. Connue pour des allergies, anxieuse et agitée. Perd brutalement connaissance et les urines. VA perméables, FR rapide, pouls carotidien présent. Pas de réaction urticarienne franche au niveau cutané. Attitude ?

R : Administration d'adrénaline par voie IM

Choc anaphylactique, ne pas perdre du temps, la on a assez d'indice pour suspecter un choc anaphylactique et le traiter.

Perte des urines : relâchement des sphincters, s'observe svt lors de la perte de connaissance.

☐ La mesure de l'ensemble des paramètres vitaux

☐ La mesure de la glycémie capillaire

☐ La pose d'une voie veineuse périphérique

☐ L'administration d'adrénaline par voie intraveineuse

☐ L'administration d'adrénaline par voie intramusculaire

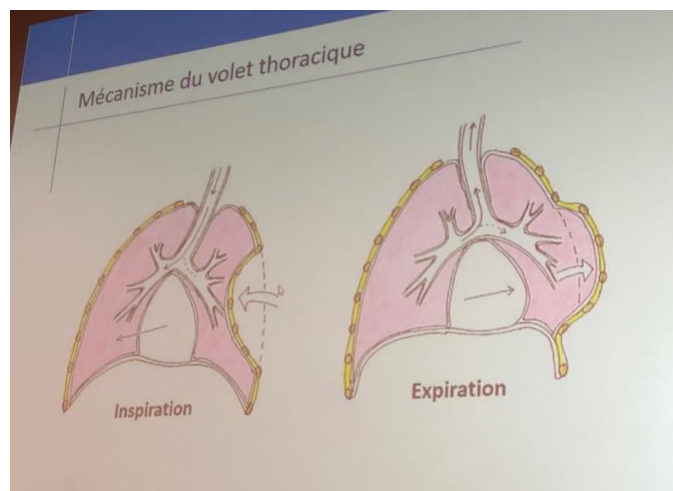
Q4 : 20 ans, AVP, commotion cérébrale et douleurs thoraciques entraînant une dyspnée. Nombreuses fractures de côtes ddc et un volet thoracique G important. Mise en place d'un drain pour aspirer un hemo-pneumothorax. Proposition thérapeutique la plus sûre pour le volet :

R : intubation et ventilation mécanique

Volet : très douloureux, nécessite protection des VA

Pneumothorax sous tension, complication = choc obstructif en raison de l'impact sur la précharge/retour veineux

Ici une photo de super qualité d'un hémithorax



- ☐ Un bandage compressif
- ☐ Une ostéosynthèse costale
- ☐ L'intubation et la mise sous ventilation mécanique
- ☐ La trachéotomie
- ☐ Une attitude conservatrice

Q5 : 43 ans, a ingéré à but suicidaire 16 comprimés de paracétamol hier soir, dépendance OH. Affirmation correcte :

- ☐ Il faut administrer de la N-acétylcystéine puis attendre le dosage de la paracétamolémie
- ☐ Il faut effectuer un dosage de la paracétamolémie et administrer de la N-acétylcystéine selon le résultat de cet examen
- ☐ En l'absence de symptômes et/ou de perturbation des tests hépatiques à ce stade, la probabilité d'une atteinte hépatotoxique ultérieure est négligeable
- ☐ Si la paracétamolémie est actuellement à 112 µg/ml, un traitement par N-acétylcystéine est indiqué.

R :

- A. Vrai
- B. Faux : vrai si < 12h.

C. Faux : première phase pauci-symptomatique, 2^e phase 2-3 jours + tard

D. Vrai : donc on continue le protocole de N-acétylcystéine

Antidote empêche la formation de DANPI ? métabo toxique du paracétamol. Les guidelines changent donc prof conseil de se mettre à jour régulièrement (merci bien), indice :

- 4 premières heures : patient n'aura pas encore tout absorbé, faire des taux répétés de paracétamolémie
- 12 premières heures : effet max de la N-acétylcystéine, mais on peut l'utiliser aussi après

Patient OH chronique, on sait pas si la N-acétylcystéine est efficace... ?

Q6 : 38 ans, connu pour épilepsie idiopathique et trouble dépressif récurrent, présente un trouble de la vigilance, a ingéré à but suicidaire env 50 comprimés d'imipramine 25mg et 30 de lorazepam 2.5mg. GCS 6/15, TA 100/70, FC 105 bpm, FR 28/min, SpO2 91%, râles grossiers bibasaux à l'auscultation. Quelle mesure la + appropriée en urgence ?

- Administrer de l'oxygène et du flumazénil : problème car elle est épileptique, donc en reversant la BZD on risque d'abaisser le seuil épileptogène et causer des convulsions
- Intubation oro-trachéale – Vrai
- Mettre la position en PLS et effectuer une recherche large de toxique
- Contacter le centre de toxicologie

GCS a été dev pour les TCC sévère, dans ces cas on intube systématiquement à GCS < 9 pour lutter contre l'hypoxie. Dans le cas des intoxications, une nouvelle étude à montrer qu'on peut ne pas intuber, sauf si on voit une évidence d'aspiration (ici râles grossiers).

Q7 : 10 ans, état confusionnel, anamnèse impossible. Agitation psychomotrice, tachycardie (135 bpm), mydriase bilat peu réactive, peau sèche, suspicion de globe urinaire. = syndrome sec Quelle substance est la plus vraisemblablement en cause ?

- Cocaïne
- Héroïne
- Agent atropinique
- Venlafaxine
- Halopéridol

R : agent atropinique (ex : belladone)

Q8 : 57 ans, EF, toux grasse, dyspnée progressive depuis 3j, confus, connu pour un DM2, HTA, BPCO. TT habituel : torasémide, lisinopril, metformine.

EF à 38.7, TA à 85/55, FC 120 bpm, FR 32, SaO2 89%, hypoventilation en base G. pH 7.36, PaCo2 à 5.8, PaO2 7.9. Créatininémie à 187. Affirmations justes :

- ATB devra être débuté en fonction du résultat des hémoch – Faux, ne pas attendre les hémoch
- En raison de la tachypnée et de l'hypoxémie, le remplissage volémique par NaCl 0.9% est CI – Faux : y a un petit risque de "mouiller" le poumon (risque de désaturer et ev. de devoir faire de la ventilation invasive), mais il a besoin de ce remplissage car est en choc septique
- Ventilation non-invasive avec aide inspiratoire augmenterait significativement les chances de survie dans cette situation – Faux : y a pas d'acidose resp, c'est une hypoxémie isolée (pneumonie hypoxémiante). La ventilation non-invasive est délétère car risque de retarder l'intubation + patient est hypotendu (ventilation administre une pression positive, ce qui diminue le retour veineux et augmente le risque de choc)
- L'ensemble de son traitement habituel doit être interrompu – Vrai : metformine à tendance à favoriser les acidoses métaboliques. Donc à suspendre le temps de stabiliser le patient.

Ici c'est un choc septique avec foyer à point de départ pulmonaire.

Q9 : 29 ans, 3 épisodes de syncope, traitée par clarithromycine depuis 2j pour une PAC.

Cachectique, FR 32, TA 100/70, FC 95 bpm, SaO2 92%. ECG : Torsade de pointe.

Quels éléments peuvent favoriser la survenue d'un tel rythme ?

- Méthadone – Vrai
- Anorexie - Vrai
- Antibiotique - Vrai
- Paramètres hémodynamiques - Faux

Torsade de pointe = TV polymorphe, favorisé par :

- QT long congénital
- QT long acquis : DHBP (= dompéridon, anti-émétique), neuroleptiques, amiodarone, HypoMg, HypoK, HypoCa, méthadone¹...

Q10 : 28 ans, AVP, collision frontale, pas de ceinture. Inconscient, réaction de retrait à la douleur, transporté non intubé aux urgences. Pâle, TAs 80, 120 bpm, pupilles contractées et isocores, fausse mobilité de la jambe D en-dessous du genou. Quelle est la mesure la moins urgente dans les 20 premières minutes ?

- Stabilisation de la colonne cervicale - Faux
- Imagerie thoracique - Faux
- US de l'abdomen - Faux
- Rx de la jambe D – Vrai
- 2 VVP - Faux

Q11 : 32 ans, DRS d'apparition brusque, 120 bpm, 175/110, SaO2 97% sous O2 au lunettes, FR 34. Il a consommé de la cocaïne peu avant les douleurs, actuellement évaluées à 7/10.

Traitement ?

- Aspegic 250 mg iv - Vrai
- Labétalol 10 mg iv - Faux
- Métoprolol 5 mg iv - Faux
- Lorazépam 2.5 mg sl – Vrai

Lorazépam : diminuer l'hyper-adrénergisme en évitant d'utiliser trop de BZD, permet de réduire le phénomène d'opposition qui favorise l'HTA.

Eviter les bbloquant pur sélectif, car peut favoriser l'hypertension en raison du fait que les récepteurs alpha sont pas contre-balançé ? on peut utiliser par ex l'urapidil (alpha bloquant pur), le trendate (car effet alpha) ... blablabla

Aspegic : car il a des douleurs thoraciques, en attendant le résultat de la troponine on donne de l'aspirine. Cocaïne a un effet pro-coagulation (ou pro-plaquettaire ?) et fait vasospasme + usage chronique favorise la maladie coronarienne. Donc patient cocainomane est + à risque de faire un IM.

Q12 : 76 ans, vertiges ne lui permettant plus de se lever, a chuté plusieurs fois durant les 2 derniers jours. Atcd : HTA mal contrôlée, adjonction d'un diurétique au traitement d'amlodipine et de ramipril. Examen neuro sp. Bilan : créat 135, urée 23.2, créatinine kinase 535, troponine T 6ng. Quel examen complémentaire nous donnerait le + vraisemblablement le diagn ?

- Electronystagmographie – non (je sais même pas ce que c'est)
- Épreuve calorique vestibulaire - nop

¹ Faire un ECG à chaque contrôle

- IRM cérébrale - non
- Schellong – Vrai : plusieurs FR d'hypotension orthostatique avec tt anti-hypertenseur important et diurétique. Origine cardiaque peu probable.
- Holter - non

Q13 : 46 ans, présente des céphalées intenses décrites comme insupportables, FC 92 bpm, normocarde, SO2 98%, FR à 20/min. A reçu 1g de Daf qui a fait diminuer la douleur à 6/10, examen neuro normal. Atcd de colique néphrétique, et kystes rénaux. Attitude ?

- CT/scan cérébral en urgence – Vrai : risque d'HSA, red flag de céphalées en coup de tonnerre
- PL en urgence - non
- O2 aux lunettes pendant 30 min - non
- Administration d'un sumatriptan - non
- RAD sous daf et AINS - non

Q14 : 72 ans, ECA, abdomen tendu et douloureux avec défense aux 4 quadrants. Marbrures généralisées. T à 35.3, FR 40, TA 90/50, FC 120, SaO2 90%. Proposition :

☐ Remplissage vasculaire > 1000 ml de cristalloïdes

☐ Remplissage vasculaire > 1000 ml de cristalloïdes et réaliser un scanner abdominal

☐ Remplissage vasculaire > 1000 ml de cristalloïdes, prélever 2 paires d'hémocultures et administrer 2g de ceftriaxone iv

☐ Débuter une perfusion d'adrénaline IV

☐ Débuter une perfusion de noradrénaline IV

R : remplissage vasculaire, hémoch et ceftriaxone (suspicion de choc septique)

Q15 : 76 ans, ECA, incapable de se relever du sol de son domicile, dernier contact avec sa famille il y a 24h, pas de TT particulier. Paramètres les + compatibles avec cette histoire ?

- Hyperkaliémie – Vrai
- Hyponatrémie - Faux
- ALAT augmentée - Faux
- ASAT augmentée – Vrai

Rhabdomyolyse —> fait monter le potassium. ASAT sont aspécifique, il y en a aussi dans les CML.

Q16 : 42 ans, dyspnée apparue après avoir rempli le remorque-citerne avec un produit phytosanitaire dans un local fermé et moteur qui tournait. TA 100/60, 48 bpm, FR 23/min, pupilles en myosis, salivation importante. PEC :

- Physostigmine - non
- Atropine – Vrai
- Naloxone - non
- Flumazénil - non
- Oxygène 100% au masque – non

Intoxication aux organophosphorés (dans les pesticides), syndrome cholinergique

Q17 : 62 ans, trouble bipolaire traitée par lithium depuis plrs années, retrouvée confuse à côté d'une boîte de lithium de 50 comprimés complètement vide. Ne sait plus combien de comprimés elle a ingéré. Ataxie, dysarthrie.

Lithiémie à 6.2, créatinine à 220, hypernatrémie à 150. PEC ?

- Charbon actif
- Furosémide iv
- Laxatif
- Hémodialyse – Vrai
- Aucune de ces réponses n'est juste